

BÁO CÁO PHÂN TÍCH STAKEHOLDER HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ (EHR)

Dự án RikkeiCare EHR

Chủ đề: Thanh lọc Stakeholder - Power/Interest Matrix - Xử lý xung đột Privacy vs Convenience

1. Thanh lọc danh sách Stakeholder

Theo quy tắc nghiệp vụ, Stakeholder phải là cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức có quyền lợi, vai trò hoặc chịu ảnh hưởng bởi hệ thống. Thiết bị, phần mềm và cơ sở dữ liệu không được xem là Stakeholder.

Đối tượng khảo sát	Kết luận	Loại	Lý do
Bác sĩ điều trị trực tiếp	Giữ lại	Stakeholder	Người trực tiếp sử dụng EHR để khám, xem lịch sử bệnh và ra quyết định điều trị.
Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle	Loại bỏ	Thực thể kỹ thuật	Là hạ tầng kỹ thuật lưu trữ dữ liệu; không có quyền lợi, vai trò hay ý chí trong dự án.
Ban Giám đốc Bệnh viện RikkeiCare	Giữ lại	Stakeholder	Tổ chức/cấp quản lý có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về dự án.
Bệnh nhân và Thân nhân người bệnh	Giữ lại	Stakeholder	Là đối tượng hưởng lợi và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cách hệ thống quản lý, cung cấp và bảo vệ dữ liệu sức khỏe.
Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế (Bộ Y tế)	Giữ lại	Stakeholder	Cơ quan bên ngoài có quyền giám sát tuân thủ, bảo mật và pháp lý đối với dữ liệu y tế.

Kết luận thanh lọc: 4 Stakeholder thực thụ là Bác sĩ điều trị trực tiếp, Ban Giám đốc Bệnh viện RikkeiCare, Bệnh nhân & Thân nhân và Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế. Máy chủ Oracle chỉ là thực thể kỹ thuật.

2. Ma trận Quyền lực - Mức độ quan tâm (Power-Interest Matrix)

Việc xếp Stakeholder dựa trên mức độ họ có thể tác động đến quyết định dự án và mức độ họ quan tâm trực tiếp đến kết quả EHR.

Nhóm chiến lược	Tiêu chí	Stakeholder	Hành động tương tác chủ chốt
Quản lý chặt chẽ	Quyền lực Cao - Quan	Ban Giám đốc Bệnh viện	Báo cáo tiến độ trực tiếp,

Nhóm chiến lược	Tiêu chí	Stakeholder	Hành động tương tác chủ chốt
(Manage Closely)	tâm Cao		tham gia mọi quyết định lớn.
Giữ hài lòng (Keep Satisfied)	Quyền lực Cao - Quan tâm Thấp	Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế (Bộ Y tế)	Cung cấp hồ sơ tuân thủ và báo cáo các kiểm soát quan trọng; tham vấn khi có thay đổi ảnh hưởng pháp lý.
Giữ thông tin (Keep Informed)	Quyền lực Thấp - Quan tâm Cao	Bác sĩ điều trị trực tiếp	Cập nhật thường xuyên về luồng nghiệp vụ và xin phản hồi về khả năng sử dụng EHR trong khám chữa bệnh.
Giám sát tối thiểu (Monitor)	Quyền lực Thấp - Quan tâm Thấp	Bệnh nhân và Thân nhân (ở cấp độ quản trị dự án)	Thông báo định kỳ qua email/app, không cần họp riêng.

Lưu ý về nguyên tắc xếp hạng: “Quyền lực” được hiểu là khả năng tác động đến quyết định và tuân thủ của dự án, không phụ thuộc vào việc một đối tượng có giá trị tài sản cao hay không. Vì vậy máy chủ Oracle không được đưa vào ma trận Stakeholder.

3. Giải pháp dung hòa xung đột Bác sĩ - Pháp chế

Giải pháp đề xuất: Thiết kế cơ chế phân quyền theo vai trò và Consent: bác sĩ phải xác thực/được cấp quyền trước khi xem dữ liệu nhạy cảm; riêng khi bệnh nhân hôn mê, bất tỉnh hoặc không thể cung cấp mã xác nhận trong tình huống cấp cứu, hệ thống cho phép **Emergency Override** để bác sĩ mở thông tin cần thiết cho cấp cứu, đồng thời bắt buộc ghi đầy đủ audit log (người truy cập, thời điểm, bệnh nhân, lý do và phạm vi dữ liệu được mở) để phục vụ hậu kiểm pháp lý.

4. Nguyên tắc nghiệp vụ rút ra

- Stakeholder là con người/tổ chức; hệ thống, phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu chỉ là thực thể kỹ thuật hoặc thành phần hệ thống.
- Power-Interest Matrix dùng để quyết định cách quản lý và giao tiếp với Stakeholder, không dùng để đánh giá giá trị tài sản của thiết bị.
- Xung đột giữa tiện ích truy cập và bảo mật phải được giải quyết bằng kiểm soát truy cập theo vai trò, Consent và cơ chế Emergency Override có kiểm toán.

5. Bảng đáp án ngắn gọn

Nội dung	Đáp án
Thực thể cần loại bỏ	Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle
Manage Closely	Ban Giám đốc Bệnh viện RikkeiCare
Keep Satisfied	Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế (Bộ Y tế)
Keep Informed	Bác sĩ điều trị trực tiếp
Monitor	Bệnh nhân và Thân nhân
Cơ chế xử lý cấp cứu	Emergency Override + Audit Log khi bệnh nhân không thể Consent

--- HẾT ---